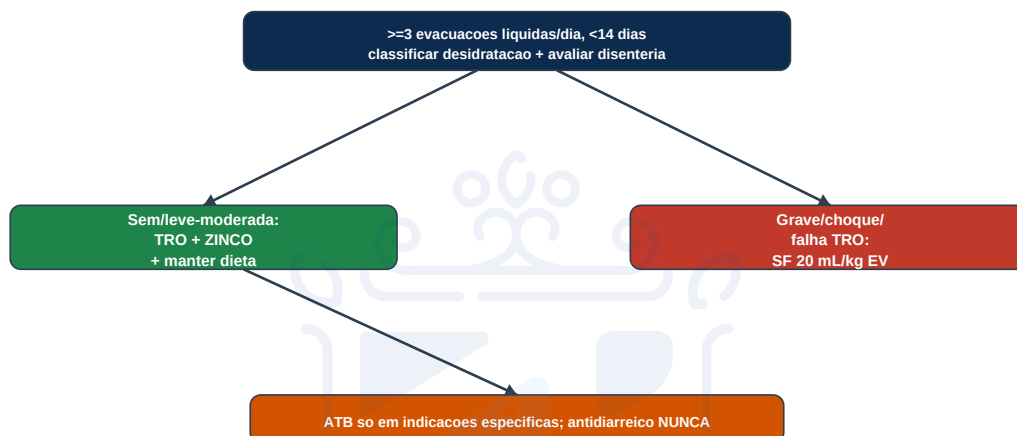


## DIARREIA AGUDA NA CRIANÇA — TRO + ZINCO

### FLUXOGRAMA — O RISCO É A DESIDRATAÇÃO

#### DIARREIA — CLASSIFICAR DESIDRATAÇÃO E HIDRATAR



### DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

#### O QUE É

- >= 3 evacuações amolecidas/líquidas por dia, com duração < 14 dias
- O risco NÃO é a diarreia em si, mas a PERDA hídrica e eletrolítica
- VIRAL (mais comum): rotavírus, norovírus, adenovírus -> fezes aquosas, febre baixa, vômitos
- BACTERIANA: E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter -> febre alta, muco/SANGUE, toxemia
- Parasitária (arrastada); outras: pós-ATB, intolerância à lactose secundária, ITU em lactentes

### CLASSIFICAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO

| Grau              | Achados                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem desidratação  | Ativo, mucosas úmidas, olhos normais, diurese preservada                                                                  |
| Leve-moderada     | Sede/irritabilidade, olhos levemente fundos, mucosas secas, diurese reduzida, turgor discretamente lento                  |
| Grave             | Letargia/rebaixamento, olhos muito fundos, extremidades frias, oligoanúria, pulso fraco/taquicardia, hipotensão (tardia!) |
| Marcador objetivo | Perda de peso recente é o melhor parâmetro                                                                                |

### QUANDO INVESTIGAR / RED FLAGS

#### EXAMES E ALARME

- Exames (hemograma, Na/K, ureia/creatinina, gaso) se: diarreia com SANGUE, febre alta/toxemia, desidratação grave, lactente < 3 meses, falha terapêutica
- Coprocultura/parasitológico em quadros prolongados ou graves
- Disenteria (sangue/muco + febre) sugere etiologia bacteriana invasiva
- Sinais de gravidade: rebaixamento, choque, oligoanúria, vômitos incoercíveis
- Lactentes pequenos desidratam mais rápido — atenção redobrada

## TRATAMENTO — HIDRATAÇÃO É O PILAR

### Rx TRO / EV + ZINCO

TRO (principal): SRO 50 mL/kg (leve) ou 75-100 mL/kg (moderada) em 4h, em pequenos volumes frequentes  
Reidratação VENOSA (grave/choque/vômitos incoercíveis/rebaixamento/falha da TRO): SF 0,9% 20 mL/kg em bolus (reavaliar) -> manutenção (Holliday-Segar)  
ZINCO (reduz duração/recorrência): < 6 meses 10 mg/dia; >= 6 meses 20 mg/dia, por 10-14 dias  
Manter alimentação habitual; NUNCA suspender o aleitamento materno; sem dietas restritivas  
Ondansetrona 0,15 mg/kg/dose se vômitos (facilita a TRO)  
ANTIDIARREICOS são CONTRAINDICADOS

## ANTIBIÓTICO — NÃO DE ROTINA

### Rx INDICAÇÕES ESPECÍFICAS

Indicações: shigelose, cólera, Salmonella em lactentes/immunodeprimidos, sepse/quadro invasivo confirmado  
Criança até 30 kg (>= 3 meses, sem imunodef.): Azitromicina 10 mg/kg/dia no 1o dia, depois 5 mg/kg/dia por 4 dias; ou Ceftriaxona 50 mg/kg IM/dia por 3-5 dias  
< 3 meses ou imunodeprimido: Ceftriaxona 50-100 mg/kg EV/IM/dia por 3-5 dias  
> 30 kg (> 10 anos): Ciprofloxacino 500 mg VO 12/12h por 3 dias; ou Ceftriaxona  
A maioria das diarreias é viral e autolimitada — ATB não acelera a recuperação

## INTERNAÇÃO x ALTA

### DECISÃO

- ☐ INTERNAR: desidratação grave, choque, rebaixamento, vômitos impossibilitando TRO, disenteria com toxemia/sepse, lactente < 3 meses, comorbidade, falha ambulatorial
- ☐ ALTA: sem/leve desidratação, aceitando líquidos VO, retorno garantido, responsáveis orientados
- ☐ Casa: SRO conforme aceitação, dieta habitual/aleitamento, zinco, antiemético se necessário
- ☐ Repor após cada evacuação/vômito; NÃO usar refrigerante/suco/chá como reidratação
- ☐ Retorno IMEDIATO: letargia, recusa de líquidos, oligúria, febre alta, sangue nas fezes, piora após 48h

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança \_\_\_\_ anos/\_\_\_\_ kg com diarreia aguda há \_\_\_\_; aspecto das fezes \_\_\_\_ (sangue/muco?); desidratação \_\_\_\_.
- Sinais vitais \_\_\_\_; diurese \_\_\_\_; toxemia/sepse: \_\_\_\_; eletrólitos: \_\_\_\_.
- Condutas: TRO \_\_\_\_ / SF 0,9% 20 mL/kg bolus \_\_\_\_; zinco; ATB \_\_\_\_ (se indicado).
- Solicito internação (grave/choque/sepse/lactente < 3 meses) — vigilância de débito urinário.

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança de 2 anos com diarreia aquosa, sem sangue, desidratação leve, aceitando líquidos. Qual a conduta?

- A) Hidratação venosa imediata
- B) Terapia de reidratação oral + zinco, mantendo a dieta
- C) Antibiótico oral empírico
- D) Antidiarreico (loperamida)
- E) Jejum por 24h

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual suplemento reduz a duração e a recorrência da diarreia aguda na criança?

- A) Ferro
- B) Zinco (10-20 mg/dia por 10-14 dias)
- C) Vitamina C
- D) Cálcio
- E) Magnésio

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Em qual situação está indicado antibiótico na diarreia aguda pediátrica?

- A) Toda diarreia com febre
- B) Shigelose, cólera, Salmonella em lactentes/imunodeprimidos ou quadro invasivo/sepsis confirmados
- C) Diarreia aquosa viral
- D) Sempre que houver vômitos
- E) Diarreia de 1 dia de duração

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o uso de antidiarreicos na criança, é correto:

- A) São a base do tratamento
- B) São CONTRAINDICADOS
- C) Devem ser usados se houver sangue nas fezes
- D) Substituem a hidratação
- E) Reduzem a mortalidade

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual achado nas fezes sugere etiologia bacteriana invasiva (disenteria)?

- A) Fezes aquosas sem muco
- B) Sangue e muco com febre alta e toxemia
- C) Fezes espumosas
- D) Fezes esverdeadas isoladas
- E) Ausência de qualquer alteração

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Diarreia aquosa com desidratação leve trata-se com terapia de reidratação oral + zinco, mantendo a dieta e o aleitamento. Antidiarreicos são contraindicados; ATB não é de rotina (maioria viral).

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

O zinco (10 mg/dia em < 6 meses; 20 mg/dia em ≥ 6 meses, por 10-14 dias) reduz a duração e a recorrência da diarreia aguda — recomendado pela OMS.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

Antibiótico é indicado em situações específicas: shigelose, cólera, Salmonella em lactentes/imunodeprimidos, e quadros invasivos/sepsis confirmados — não na diarreia viral aquosa.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

Os antidiarreicos (ex.: loperamida) são contraindicados na criança (risco de íleo, megacólon e mascaramento), inclusive na disenteria. O pilar é a hidratação.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

Sangue e muco nas fezes com febre alta e toxemia caracterizam disenteria, sugerindo etiologia bacteriana invasiva (Shigella, Campylobacter, Salmonella, E. coli invasiva).

SM24  
Suporte ao Plantão Médico